Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 97, Sede Administrativa do Edifício Centro Gaúcho - 4º andar - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3029-7000 - Email: frsantmari3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5029455-76.2023.8.21.0027/RS

AUTOR: VITORIA LIPPERT FORNEL (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))

RÉU: UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos.

VITORIA LIPPERT FORNEL, por meio de sua representante legal EDILA DIAS LIPPERT, ajuizou *ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de tutela antecipada de urgência* em face de **UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, todos qualificados na inicial. Relatou que a autora, menor impúbere, mantém vínculo com o plano de saúde Unimed e apresenta quadro de Transtorno de Espectro Autista nível 3 não verbal (CID 11 6A02.Z). Contou que realiza todas as terapias indicadas pelo neuropediatra na Clínica Mundo Novo desde setembro de 2021. Explicou que devido ao seu comportamento opositor em terapias e dificuldade de socialização, o neuropediatra recomendou a manutenção das terapeutas, devido ao vínculo criado e visando evitar atraso no seu desenvolvimento psicomotor. Disse que realiza duas sessões semanais de fonoterapia, duas sessões semanais de educação especial, duas sessões semanais de terapia ocupacional, duas sessões semanais de psicomotricidade e uma sessão semanal de musicoterapia. Apesar da prescrição médica, afirmou que a Unimed se recusou a cobrir a integralidade do tratamento indicado, pois este deveria ser buscado em clínicas conveniadas. Discorreu sobre o direito aplicável ao caso. Argumentou o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela provisória de urgência. Ao final, requereu a procedência da ação, de modo a condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na cobertura da integralidade do tratamento prescrito por médico especialista. Solicitou AJG. Juntou documentos (demais documentos do Evento 1).

Deferida a AJG à parte autora e concedida em parte a tutela provisória. Ainda, determinada a intimação do Ministério Público, invertido o ônus da prova, esclarecida a não designação de audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida (evento 4, DESPADEC1).

Citada (evento 11, CERTGM1), a parte requerida UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA apresentou contestação (evento 17, CONT1). Preliminarmente, arguiu a falta de interesse de agir e a inépcia da inicial. No mérito, comprovou o cumprimento da medida liminar deferida, bem como que já vinha reembolsando a autora em alguns meses anteriores ao deferimento da medida, esses, limitados aos valores praticados pela Operadora com seus prestadores para o mesmo tipo de atendimento e descontada a coparticipação. Sustentou que nunca houve negativa da prestação de atendimento à autora, sendo apenas oferecido-lhe Clínica Credenciada para a realização do seu tratamento, momento em que a autora escolheu pelo tratamento particular, em Clínica não credenciada, o que deve ser arcado por suas própias custas. Dissertou que o reembolso integral das terapias realizadas na Clínica Mundo Novo não merece acolhimento, conforme a decisão que julgou o agravo de instrumento interposto pela autora e demais jurisprudências. Sinalou a legalidade da cobrança de cooparticipação, expressamente contratada pela autora e permitida por lei. Ao final, pugnou: a) pela extinção da ação sem resolução de mérito por falta de interesse de agir; b) pelo indeferimento da inicial por esta ser inepta; c) pela improcedência da ação, e, alternativamente, pelo deferimento do reembolso de forma parcial, nos limites da tabela praticada pela Operadora junto a seus prestadores, descontada a coparticipação. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 21, RÉPLICA1).

Intimadas as partes para se manifestarem acerca das questões de fato e de direito importantes para o julgamento da lide, bem como sobre o interesse na dilação probatória (evento 22, ATOORD1).

A parte autora informou não ter interesse na produção de outras provas (evento 28, PET1) e juntou laudo médico (evento 29, PET1 e evento 29, LAUDO2).

A parte requerida ressaltou suas teses e manifestou não ter outras provas a produzir (evento 30, PET1).

Determinada vista às partes do laudo juntado pela autora, bem como vista ao Ministério Público para parecer final (evento 35, DESPADEC1).

A requerida manifestou-se informando sobre a necessidade da apresentação laudo médico e plano terapêutico atualizado, diante de deliberação do conselho de direção, que estipula a necessidade de atualização contínua, cada 6 meses, dos referidos documentos. Também informou da criação do “Projeto TEA”, sendo que através desse projeto, se colou à disposição, ofertando a equipe médica do Projeto TEA para que seja realizada essa reavaliação, a fim de gerar menos custos a família (evento 43, PET1).

A autora peticionou informando que a aprtir de outubro de 2024 a parte ré passou a descumprir a decisão da liminar deferida em 2ª Instância, onde o recurso foi parcialmente provido, determinando que a agravada realizasse o reembolso integral, apenas com o desconto da coparticipação. Requereu que a requerida passe a cumprir a decisão, com aplicação de multa em caso de inadimplemento (evento 49, PET1).

A requerida peticionou alegando que a decisão do Agravo de Instrumento entendeu que existe a necessidade de o tratamento da autora continuar sendo feito na Clínica Mundo Novo, observando-se os limites do contrato firmado entre as partes, sendo que o reembolso está limitado aos valores praticados pela Operadora com seus prestadores para o mesmo tipo de atendimento e descontada a coparticipação (evento 51, PET1).

Dada vista ao Ministério Público para manifestação sobre as petições (evento 52, DESPADEC1).

A autora novamente peticionou infomando que enquanto não haver a análise do descumprimento da liminar pela requerida, e sua condenação à multa, não terá condições de custear integralmente os valores das terapias, sendo que já está tendo que pensar em deixar de realizar algumas, o que irá prejudicar a menor. Requereu, dessa forma, a análise antecipada da petição do evento 49, antes da prolação da sentença (evento 57, PET1).

Esclarecido que não assiste razão à autora, já que o Agravo de Instrumento, embora julgado parcialmente provido, para fins de que o tratamento da autora siga sendo realizado junto à clínica que já lhe atende (processo 5314792-82.2023.8.21.7000/TJRS, evento 88, RELVOTO1), manteve a decisão que, por maioria, vencida a relatora (processo 5314792-82.2023.8.21.7000/TJRS, evento 52, ACOR2)**1**, considerou que o reembolso deve obedecer os limites do contrato.

O Ministério Público apresentou parecer final (evento 66, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Julgo o feito no estado em que se encontra, com fulcro no art. 355, I**1**, do CPC/2015, pois os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do meu convencimento, bem como para solucionar a lide, somado à ausência de interesse das partes na produção de provas.

Existindo preliminares pendentes para análise, passo a sua apreciação.

Da falta do interesse de agir

A parte requerida alegou a falta de interesse de agir da parte autora, levando em consideração que não houve negativa de atendimento por parte da ré, sendo que a autora nem mesmo havia realizado pedido formalizado junto à requerida.

A preliminar não prospera.

Isso porque, apesar de haver o envio de email para a requerida a fim de solicitar os atendimentos necessários à parte autora (evento 1, EMAIL18), o que já configuraria uma negativa.

Por outro lado, a parte ré apresentou contestação (evento 17, CONT1), o que indica que se houvesse pedido administrativo referente aos moldes dos pedidos da lide, este não seria concedido, pelo que a preliminar vai afastada.

Da inépcia da inicial

A requerida arguiu ainda a inépcia da petição inicial, fundamentada no fato de a narração dos fatos não decorre logicamente à conclusão, havendo pedidos incompatíveis entre si.

Analisando a petição inicial, verifico que não assiste razão à demandada, isto porque a exordial atende a todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC e não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no artigo 330, §1º, do referido diploma legal.

Vencidas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Do mérito

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora, menor impúbere, representada por sua genitora, apresenta um quadro de Transtorno de Espectro Autista, nível 3, não verbal, o qual impacta profundamente seu desenvolvimento e inserção social. Salientou que mantém vínculo com o plano de saúde Unimed, todavia, que por falta de vagas e de profissionais habilitados no plano, passou a realizar seu tratamento, indicado por médico assistente, na Clínica Novo Mundo, onde já conta com cerca de 4 anos de atendimentos e progressos. Aduz que em virtude de a Clínica Novo Mundo não ser credenciada com a requerida, esta se negou à ressarcir os gastos com os tratamentos da menor, pelo que requereu a prestação jurisdicional para condenar á ré Unimed ao ressarcimento e custeio integral das terapias indicadas pelo médico assistente, junto à Clínica Novo Mundo.

De outra banda, a parte requerida alega que não possui obrigação de custear integralmente o tratamento da menor, tendo em vista que possui rede credenciada para a prestação do atendimento que ela necessita, e que se a autora optou por utilizar a rede particular é seu dever arcar com os custos. Também sustentou, alternativamente, o reembolso de forma parcial, nos limites da tabela praticada pela Operadora junto a seus prestadores, descontada a coparticipação.

A relação contratual havida entre as partes é incontroversa, a controvérsia da demanda gira em torno da obrigação da demandada ao custeio (parcial ou integral) do tratamento da criança Vitória em Clinica não credenciada com a requerida, bem como se a opção pela aludida clínica particular pela autora ocorreu por falta de vagas ou profissionais habilitados junto à requerida Unimed, na data do início dos tratamentos (2020-2021).

Destaco que, considerando a relação das partes, aplica-se ao caso a legislação consumerista, conforme já assentado anteriormente (evento 4, DESPADEC1). A parte autora encaixa-se no conceito de consumidor, consoante o art. 2º[1] da Lei 8.078/90, enquanto a demandada é considerada fornecedora nos termos do art. 3º[2] do mesmo diploma legal. Aliado a isso, aplicável a súmula 608 do STJ[3].

Delimitadas essas premissas, encaminho-me à análise.

Da obrigação da ré em custear tratamento fora da rede credenciada

Inicialmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na esteira da Lei 12.764/2012, estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura ilimitada para intervenções indicadas pelo médico assistente no tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento (RN n.º 539/2022).

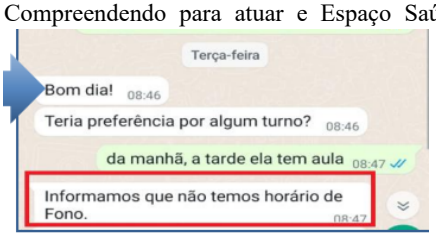
Com efeito, a alteração promovida não deixa margem para interpretações restritivas: a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar tratamento (art. 6.º, §4º[4], da RN 465/2021). Nesse sentido:

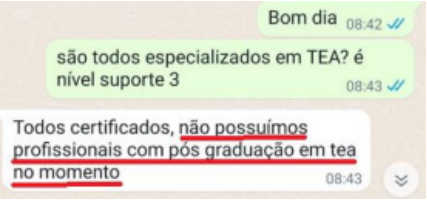
> *APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM AUTISMO. LEI COMPLEMENTAR Nº 15.145/18. ART. 6º, §4º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS, INCLUÍDO PELA RN Nº 539/2022.* ***PREVISÃO DE TRATAMENTO INTEGRAL AO PORTADOR DE TEA.*** *- O art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que dispõe sobre o IPE-SAÚDE, refere que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos. As exclusões de cobertura, segundo o §1º, abarcam os tratamentos não previstos em tabelas do próprio Instituto, contudo o entendimento do STJ, ao qual me filio, é no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado. -* ***Após a edição do art. 6º, §4º, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, incluído pela RN nº 539/2022, não há mais dúvida de que as operadoras de planos de saúde devem fornecer aos portadores de TEA o método ou a técnica indicada pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Portanto, passou a ser considerada obrigatória a cobertura para técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças.*** *A informação acerca da modificação consta do próprio site do Ministério da Saúde, na aba Agência Nacional de Saúde Suplementar, em publicação realizada em 23/06/2022. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004052620238210020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 28-02-2025)* ***(Grifei).***

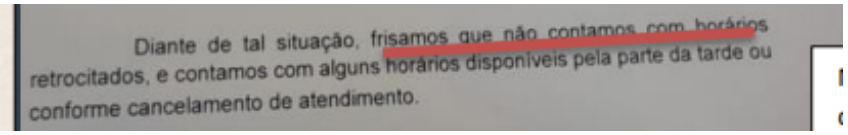
Não obstante, cabia à demandada comprovar a sua tese de que há clínicas conveniadas compatíveis com as necessidades de tratamentos da menor, com profissionais habilitados e que tenham vagas para de pronto atender a autora, sem causar prejuízos no tratamento terapêutico multidisciplinar de que, comprovamente, necessita a autora, conforme demonstrado nos substanciosos e esclarecedores atestados médicos juntados (evento 1, LAUDO9, evento 1, LAUDO10, evento 1, LAUDO11, evento 1, LAUDO12, evento 29, LAUDO2).

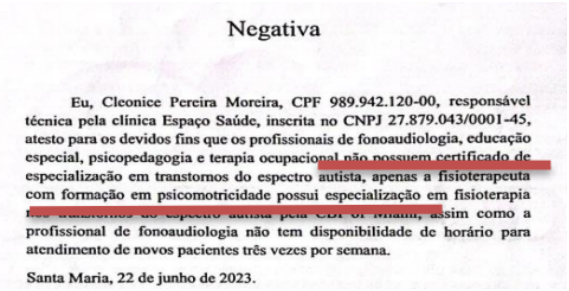
Ocorre que não há nos autos comprovação suficiente da ré que estes requisitos foram contemplados pelas suas clínicas conveniadas e que portanto não seria necessário o atendimento em clínica particular.

Ademais, a autora comprovou que entrou em contato com outras Clínicas requerendo a infomação de vagas e de profissionais especializados em TEA (evento 21, RÉPLICA1), obtendo resposta negativa, a exemplo das Clínicas Compreendendo para atuar e Espaço Saúde, credenciadas na rede da requerida (evento 21, RÉPLICA1, págs. 4/6).






Diante de tal situação, frisamos que não contamos com horários retrocitados, e contamos com alguns horários disponíveis pela parte da tarde ou conforme cancelamento de atendimento.


Negativa

Eu, Cleonice Pereira Moreira, CPF 989.942.120-00, responsável técnica pela clínica Espaço Saúde, inscrita no CNPJ 27.879.043/0001-45, atesto para os devidos fins que os profissionais de fonoaudiologia, educação especial, psicopedagogia e terapia ocupacional não possuem certificado de especialização em transtornos do espectro autista, apenas a fisioterapeuta com formação em psicomotricidade possui especialização em fisioterapia nos distúrbios do espectro autista pela CBI of Miami, assim como a profissional de fonoaudiologia não tem disponibilidade de horário para atendimento de novos pacientes três vezes por semana.

Santa Maria, 22 de junho de 2023.

Destarte, na esteira do alentado parecer ministerial (evento 66, PROMOÇÃO1) e diante da urgência e necessidade de que o tratamento da autora não sofra descontinuidade e maiores prejuízos pela troca de equipe multidisciplinar (a qual já vem sendo acompanhada pelos profissionais da Clínica Mundo Novo desde 2021), bem como seja realizado por profissionais devidamente habilitados, o pleito da parte autora prospera.

Veja-se, a propósito, os seguintes julgados do TJRS:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA.* ***PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. AUSENTE REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL PARA ATENDER A PRESCRIÇÃO MÉDICA NA FREQUÊNCIA ESTABELECIDA. DEVER DE COBERTURA JUNTO AOS PROFISSIONAIS PARTICULARES.*** *PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. 1) A despeito das novas abordagens terapêuticas que passo a passo vêm se integrando ao escopo multidisciplinar da terapia para o TEA, a obrigação das operadoras dos planos de saúde é a de*

oferecer apenas as terapias que possam ser executadas por profissional de saúde habilitado para a sua realização, observada a legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais. 2) Na medida em que a controvérsia relaciona-se às terapias de fonoaudiologia pelos métodos Prompt e CAA; terapia ocupacional com Integração Sensorial de Ayres; Terapia ABA, a qual é aplicada por psicólogo, além de consultas com nutricionista e neurologista pediátrica, ambas especializadas em autismo infantil, as quais constam expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o dever de custeio, pela operadora do plano de saúde, resta configurado. ***3) Consoante artigo 4º da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, relativamente aos profissionais que deverão aplicar as terapias prescritas e deferidas, a regra para a cobertura das terapias é que sejam prestadas por profissionais credenciados à operadora do plano de saúde contratado, cabendo à esta a indicação de profissionais habilitados nas terapias indicadas pelo médico assistente, com a especialidade condizente. 4) No entanto, não havendo a referida indicação, ao efeito de não atrasar o tratamento indicado pelo médico assistente, a jurisprudência compactua da possibilidade de compelir o plano de saúde a custear as terapias com os profissionais da escolha dos familiares, com reembolso integral das despesas gastas, com exceção da coparticipação, se previamente contratada. 5) Caso dos autos em que a requerida não conta com rede credenciada disponível para atender o menor, razão pela qual afere-se a probabilidade do direito da parte autora e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 6) Sendo assim, não tendo havido indicação de clínica credenciada e com disponibilidade para o atendimento, até que o quadro se altere, o autor faz jus ao direito de cobertura das terapias realizadas junto aos profissionais que já o atendem.*** *7) Considerando o julgamento de mérito do recurso principal, resta prejudica a análise do Agravo Interno, tendo em vista a perda do objeto. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.(Agravo de Instrumento, Nº 53357647320238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 25-04-2024)****(Grifei)****.*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ESPÉCIE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CUJO GÊNERO TEM PREVISÃO NO ROL. (...) O tratamento deve ser realizado, preferencialmente, dentro da ***rede credenciada****.* ***Em caso de inexistência de prestador dentro da rede credenciada cabe ao plano indicar prestador fora da rede credenciada, nos termos do disposto no art. 4º da RN 259 da ANS.****AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 52308413020228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-09-2023)* ***(Grifei).***

Assim, se determinado tratamento ou método está incluído na cobertura do plano de saúde, e se esta não detém ou não mencione clínica conveniada que possa prestar esse atendimento, não é legítimo negar ao segurado o custeio do tratamento em clínica particular por ele escolhida, que atenda às exigências atestadas pelo médico assistente.

Com efeito, no caso em apreço, é manifesta a necessidade de continuidade das terapias prescritas pelo médico assistente, as quais vêm sendo regularmente realizadas em clínica particular, evidenciando-se, portanto, a imprescindibilidade da manutenção do tratamento no local onde a autora já se encontra em acompanhamento, a fim de preservar a sua evolução terapêutica e evitar qualquer prejuízo à sua saúde.

Dos parâmetros de custeio e reembolso

Por outro lado, estabelecida a obrigação da cobertura, resta definir os parâmetros para o reembolso de valores. Como regra, ocorrendo o tratamento fora da rede credenciada, por opção do beneficiário e existindo disponibilidade na rede, o reembolso deve limitar-se aos valores que a operadora despenderia com seus prestadores conveniados.

Diversamente, se comprovada a indisponibilidade da rede credenciada, o reembolso deve ser integral. Veja-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DISRAFISMO OCULTO. REEMBOLSO INTEGRAL. REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ***1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o beneficiário faz jus ao reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada, em situações excepcionais, tais como a urgência na realização do procedimento e na hipótese em que não ofertado o tratamento na rede credenciada.*** *Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde. 3. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da negativa de custeio de procedimento cirúrgico de urgência. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.208.747/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).* ***(Grifei).***

No caso, a parte autora comprovou que no momento não existiam vagas para a prestação das terapias na rede credenciada da requerida, diferentemente da demandada, que não se desencumbiu de seu ônus probatório. Destarte, o reembolso do tratamento da parte autora junto à Clínica particular Mundo Novo deverá ser integral, enquanto não haver comprovação de vagas disponíveis na rede credenciada.

Em complemento, não foi juntado o contrato celebrado entre as partes, a fim de visualizar a existência de coparticipação e de seu percentual, caso existente.

Nesse sentido, a coparticipação somente é devida se contratada expressamente (art. 16, VIII[5], da Lei n.º 9.656/98). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ***TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDE CREDENCIADA. COPARTICIPAÇÃO****. I. CASO EM EXAME 1. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM QUE BUSCA A PARTE AUTORA A COBERTURA DE* ***TRATAMENTO*** *MULTIDISCIPLINAR EM RAZÃO DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR: (I) A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE DOS TRATAMENTOS EQUOTERAPIA E REUNIÕES DE EQUIPE; (II) A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DA* ***REDE CREDENCIADA****, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS APTOS AO ATENDIMENTO; (III)* ***A LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO****. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. [...]. 4. [...].* ***5. A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ENCONTRA RESPALDO NA LEI 9.656/98, ASSIM COMO ESTÁ EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO****. EMBORA LEGAL O ESTABELECIMENTO DE COPARTICIPAÇÃO, O PERCENTUAL APLICADO NÃO PODE SER EXACERBADO. [...]. IV. DISPOSITIVO6. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 52371958220238210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 22-04-2025).* ***(Grifei).***

Todavia, a afirmação da cobrança de coparticipação pela demandada não foi questionada pela autora, a qual já englobou os quadros dos cálculos anteriores devidos em sede de cumprimento da tutela provisória de urgência, da mesma forma, o próprio voto divergente, no julgamento do agravo de instrumento nº 5314792-82.2023.8.21.7000/RS (processo

5314792-82.2023.8.21.7000/TJRS, evento 52, VOTODIVERG1), foi claro ao mencionar que:

> Voltanto ao caso concreto, quando a parte recorrente pleiteia o reembolso integral, a toda evidência não deseja que o reembolso seja limitado aos valores da tabela do plano de saúde para as hipóteses de serem devidos os reembolsos **e, mesmo assim, concorda e reconhece sua obrigação de coparticipação**.
>
> Então, mesmo que se possa entender como devido o reembolso integral, não se pode excluir a coparticipação, repita-se, reconhecida pela própria parte recorrente.

Pelo exposto, dos valores a serem reembolsados deverá ser deduzido o eventual percentual de coparticipação contratualmente estabelecido, preservando-se a equação econômica originalmente pactuada.

Destarte, pela fundamentação acima exposta, a procedência dos pedidos lavrados na inicial é medida que se impõe.

ISSO POSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, **julgo procedentes** os pedidos formulado por **VITORIA LIPPERT FORNEL**, representada por sua genitora **EDILA DIAS LIPPERT**, em desfavor de **UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, para:

a) condenar a ré a custear o tratamento da autora na rede particular (Clínica Mundo Novo), de acordo com a prescrição feita pelo médico assistente (evento 29, LAUDO2), tanto no que diz respeito às diversas áreas profissionais que devem atender a autora, quanto no que diz respeito ao número de terapias por semana, **autorizada a cobrança de coparticipação, se prevista contratualmente,** enquanto perdurar a necessidade da autora, atestada pelo médico assistente a cada 6 meses;

b) confirmar a tutela de urgência deferida nos autos (evento 16, DESPADEC1), todavia, com o custeio **integral** dos valores à autora, não limitado à tabela praticada pelos prestadores credenciados à Unimed, tornando-a definitiva.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da autora, os quais fixo em R$ 4.000,00, corrigido pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora pela taxa selic (art. 406, § 1º, CCB), sem capitalização, estes últimos a partir do trânsito em julgado da presente sentença (art. 85, §16, do CPC/2015), considerando o zelo do(s) profissional(is), o tempo exigido para o serviço, o bem da vida em discussão, o lugar da prestação do mesmo, e a natureza e importância da causa (art. 85, §§2º e 8º do CPC/2015).

Tendo em vista que o §3º do art. 1.010 do CPC/2015 retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, caso interposto recurso de apelação, caberá ao Cartório abrir vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 dias (art. 1.010, §1º, do CPC/2015).

Idêntico procedimento deverá ser adotado nas hipóteses de recurso adesivo (art. 1.010, §2º, do CPC/2015) e impugnação de decisão interlocutória não agravável trazida nas contrarrazões da apelação (art. 1.009, §2º, CPC).

Após as formalidades, os autos deverão ser remetidos imediatamente ao TJ/RS.

Transcorrido o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, dê-se baixa

Publicada, registrada e intimadas as partes, automaticamente, via sistema.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO ELY FONTELA, Juiz de Direito**, em 10/08/2025, às 00:26:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10087887059v32** e o código CRC **c502ef6e**.

---

1. Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. ↩
2. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. ↩
3. Súmula 608/STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ↩
4. Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.[...]§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. ↩
5. Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:[...]VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica; ↩